

❖ 기본적 진단 검사 계획

- ① 자궁경부염/자궁내막염/자궁경관염 : CBC, ESR, CRP, 질분비물 gram 염색 및 배양검사, 질식초음파검사
 Cervical motion tenderness 있으면 자궁경부염이고, 이것이 진행되면 자궁내막염 → 자궁경관염
 → 이들은 *N. gonorrhoeae*가 원인균이고, 질염은 외음부 증상이 더 강하며, 균의 종류가 다름
- ② 세균질증/편모충질염/칸디다 질염 : Whiff test, 질분비물 산도검사, KOH 도말현미경검사, wet smear

❖ 치료 계획

- ① 세균질증 : Oral metronidazole, 너무 잦은 성교나 질 깊숙이 물로 씻어내는 습관 등으로 발병, 재발 가능, 임신 중이어도 치료함
- ② 편모충질염 : Oral metronidazole (편모충질염은 파트너도 함께 치료)
- ③ 칸디다 질염 : Oral fluconazole이나 nystatine 바르기, 임신/당뇨/항생제 사용, 환자 호발 가능
- ④ 위축성 질염 : Estrogen cream 바르기 (1~2주)
- ⑤ PID : 입원 및 정맥 항생제

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 잦은 질세척은 질 내부 환경 유지에 좋지 않으며, 감염이 생길 수 있음을 교육
- ② 위생적인 성생활, 피임 교육, 치료 성공에 대한 확신, 수치심 덜어주기
- ③ 증상 지속 시 추적 관찰 필요함을 설명
- ④ 자궁 내 장치는 감염의 원인이 될 수 있음을 설명

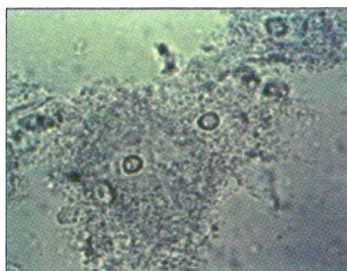
	세균성 질염	트리코모나스 질염	칸디다 질염	위축성 질염
원인	Gardnerella vaginalis	Trichomonas vaginalis	Candida species	폐경 후 호발 Estrogen 결핍
특징	회색 분비물 썩은 생선 냄새	노란색 분비물 Strawberry cervix	치즈 같은 분비물 냄새 없음	질점막 위축

wet smear	Clue cell	Trichomonas	Hyphae, Spores	정상
whiff test	+	-	-	-
pH	5~6	6~7	3~4	5~6
치료	Metronidazole 파트너의 치료는 불필요	Metronidazole 파트너 치료 필요	Antifungal drug 파트너의 치료는 불필요	에스트로겐 크림 or 질정

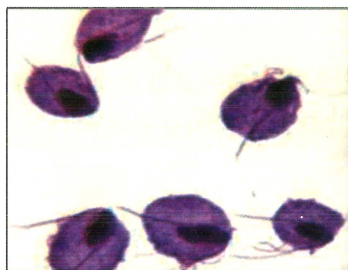
[위축성 질염]



[세균성 질염]



[트리코모나스]



[칸디다]



질출혈

❖ 기본적 진단 검사 계획

- ① 자궁 외 임신/유산 : 소변 임신반응검사, 질경유 초음파
- ② 자궁근종 : 골반초음파, 자궁난관조영술
- ③ 자궁경부암 : Pap smear & biopsy
- ④ 자궁내막암 : Endometrial aspiration biopsy
- ⑤ 갑상샘저하증 : 갑상샘 호르몬 검사

❖ 치료 계획

- ① 자궁 외 임신/유산 : methotrexate, 복강경 수술, dilatation & curettage
- ② 자궁근종 : GnRH agonist, 자궁근종절제술
- ③ 자궁경부암 : 수술, 항암 치료, 방사선 치료
- ④ 자궁내막암 : 수술, 항암 치료, 방사선 치료
- ⑤ 갑상샘저하증 : levothyroxine

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 출혈 원인 감별 후 스트레스, 체중 조절, 복용 중인 약제 조절 등 그에 따른 생활 습관 조절
- ② 정기적인 산부인과 검진으로 여성암에 대한 검진을 꾸준히 하는 것이 필요함을 교육
- ③ 위생적인 성생활, 피임 교육



keyword

질분비물 : 양, 색, 냄새, 거품/피쉬임, 통증

질출혈 : 응급, 기질적 원인 배제

질분비물 교육 : 질세척은 2~3회/주, 정기 검진 권유, 편모충은 파트너도 치료

질출혈 교육 : 응급 상황 교육

공통 교육 : 정기적 산부인과 검진

시험 관련 코멘트



월경 이상 문제에서는 제시문에 월경 이상의 종류에 대한 정보가 자세히 주어지지 않을 수 있습니다. 무월경인지, 월경과다인지, 월경통이 심해서 내원한 것인지에 대해 impression을 잡지 못하고 들어갈 수 있음을 유의합니다.

부인과 질환은 공통적으로 산과력과 월경력, 피임 방법에 대한 자세한 문진이 필요합니다. 추가적으로 비뇨기 증세 역시 함께 문진해야 함을 기억해야 합니다. **가족력이 있는 젊은 여성이 무월경을 주소로 온 경우 가장 먼저 조기 폐경을 의심합니다.** 하지만 조기 폐경 증상이 갑상샘항진증의 증상과도 비슷하므로 **갑상샘 이상 유무 역시 확인해야 합니다.**

무월경은 감별 진단이 많으니 체계적으로 외우셔야 합니다. 항상 임신을 배제한 후, 내분비적 이상(갑상샘, Hyperprolactinemia, 쿠싱) 여부를 확인합니다. 속발성의 경우 PCOS와 조기 폐경, 원발성의 경우 터너증후군을 감별해야 합니다. 이 외에도 HPO axis에 영향을 주는 스트레스나 약물 복용력도 잊지 말아야 합니다.

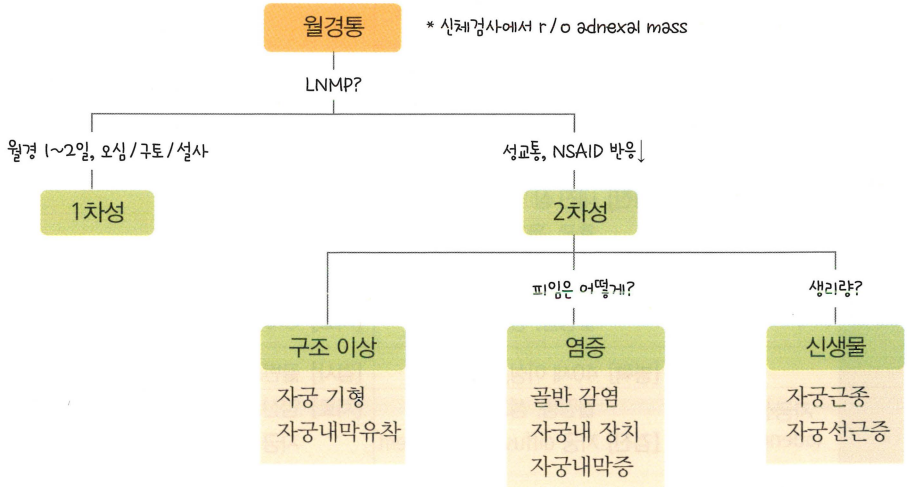
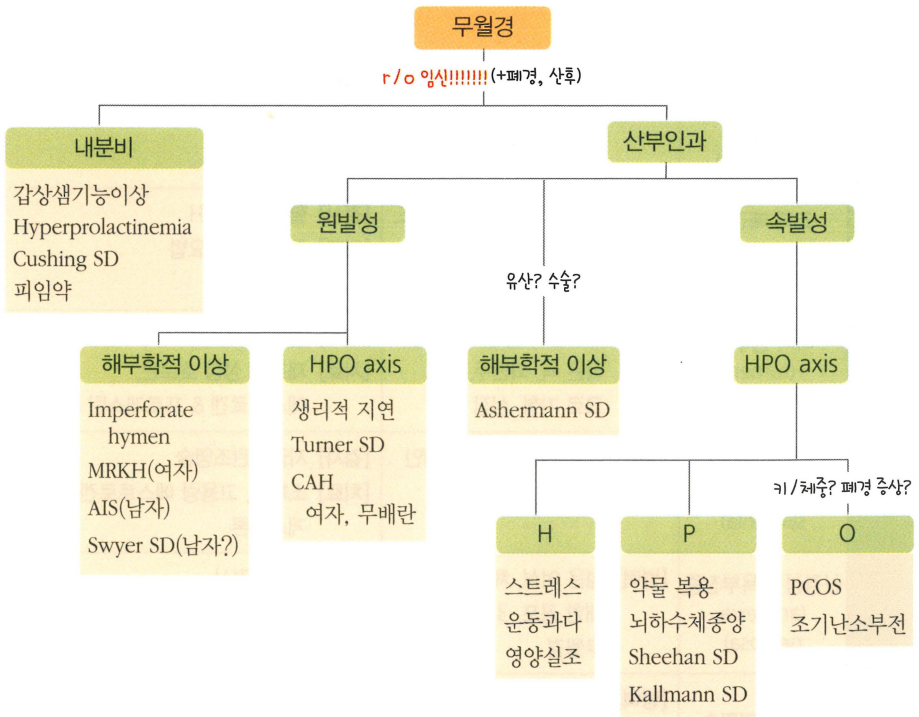
조기 폐경의 경우에는 젊은 여성, 특히 아이가 없는 경우에는 상당한 충격을 줄 수 있으므로 조심스럽게 설명하는 것이 중요합니다. 그러나 갑상샘이나 스트레스성과 같은 다른 가능성도 완전히 배제할 수 없다는 점을 강조하면서 필요한 검사를 설명합니다.

월경통의 경우 병력이 비슷하기 때문에 감별 진단이 어려울 수 있습니다. 하지만, 월경과다가 없으면서 불임을 호소하는 환자에서 자궁내막증을 주요하게 감별할 수 있음을 유의한다면 질환 감별에 도움이 됩니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
무월경	임신	[병력] 피임 안 함, 특별한 증상 없음	[검사] 임신검사 [치료] 임신 교육(산전 진찰편 참조)
	뇌하수체 질환 (prolactinoma, 뇌하수체저하증)	[병력] 무월경, 유즙 분비, 두통, 시야장애	[검사] 혈중 프로락틴 [치료] Bromocriptine, Cabergoline
	쿠싱 증후군 (Cushing syndrome)	[병력] 자색선조, 월면양 얼굴, Buffalo hump, 멍	[검사] 24시간 소변 코티솔 농도, Dexamethasone suppression test [치료] 부신절제술, 경접형동생종절제술

무월경	갑상샘항진증 (hyperthyroidism)	[병력] 만성 피로, 더위불내성, 체중 감소, 희발월경	[검사] 갑상샘 호르몬검사 [치료] 항갑상샘 약제(Propylthiouracil, Methimazole)
	다낭난소증후군★ (polycystic ovarian syndrome)	[병력] 다모증, 여드름, 체중 증가, 무월경~과다월경	[검사] 골반초음파, serum FSH/LH [치료] 체중 감량, 임신 원할 시 클로미펜, 메트포민
	조기 폐경★ (premature menopause)	[병력] 이차성 무월경, 안면홍조, 화끈거림, 땀, 열감, 두근거림, 불안, 불면증	[검사] 혈중 FSH/LH [치료] 호르몬 대체요법
	터너 증후군 (turner syndrome)	[병력] 원발성 무월경, 작은키, 작은 턱, 외반주, 요로 기형, 심장 기형	[검사] 혈중 FSH/LH [치료] 재조합 성장 호르몬, 에스트로겐 & 프로게스테인 공급
	자궁내막유착증 (intrauterine synechia)	[병력] 자궁소파술이 주된 원인	[검사] 자궁난관조영술 [치료] 소파술, 고용량 에스트로겐+프로게스테론
	신경성 식욕부진증 (anorexia nervosa)	[병력] 젊은 여성, 체중 증가에 대한 공포, 3회 이상 무월경	[검사] 전해질검사 [치료] 입원 치료, 영양 공급, 정신 치료, SSRI
월경통	원발 월경통★ (primary dysmenorrhea)	[병력] 초경 후 1~2년/월경 시작 후 48~72시간 지속 월경통, 오심, 구토 [검진] 하복부 압통	[검사] 임상적 진단 [치료] 진통제, 운동, 필요 시 경구피임제
	자궁내막증★ (endometriosis)	[병력] 25~35세, Triad : 불임, 월경통, 성교통/월경과다 없음 [검진] 내진 상 결정, 자궁이 후굴, 운동성 감소	[검사] 자궁난관조영술, 혈중 CA-125, 골반초음파, 진단적 복강경 [치료] 복강경하 수술, 프로게스테인, 다나졸 등
	자궁근종★ (uterine myoma)	[병력] 30~45세, 월경과다, 월경통, 성교통	[검사] 골반초음파, 자궁난관조영술 [치료] GnRH agonist, 자궁근종절제술
	자궁생근육증 (adenomyosis)	[병력] 40세 이상, 월경과다, 월경통, 성교통 [검진] 자궁 diffuse enlargement	[검사] 골반초음파 [치료] 임신 원할 경우 진통제, 피임제, 자궁 내 장치, 원하지 않으면 자궁절제술



STEP 1 병력 청취

무월경

먼저 오늘 문진 내용은 제가 기록은 하지만 타인은 볼 수 없고, 비밀이 유지되므로 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다. 몇 가지 질문해도 될까요?

O	생리를 얼마 동안 하지 않으셨나요?
L	-
D	-
Co	-
Ex	이전에도 이렇게 생리를 거르신 적이 있나요? → 치료는?
C = 여	[월경력] 평소에는 월경 주기가 몇 일이었나요?/규칙적이었나요? LNMP/임신 가능성/월경 기간은 몇 일이었나요? 월경량은 적당했나요?/월경통이 심하신 편이었나요? [산과력] 결혼은 하셨나요?/아이는 몇 명 있으신가요? 자연분만이었나요, 제왕절개였나요? 혹시라도 유산의 경험은 없으신가요? → (최근 출산 시) 수유 중이신가요?/출산할 때 출혈이 많았나요? 암기법 TPLA + 수유/출혈 [성관계] 마지막 성관계는 언제인가요?/성교통이 있으신가요? 피임은 하시나요?/피임 방법은 어떻게 될까요? [초경] 초경은 언제하셨나요?
A	[소화기] 구역/구토/변비/설사/통증 [비뇨기] 빈뇨/절박뇨/야간뇨/배뇨통 [전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [응급] 어지럼/호흡곤란이 있으신가요? (자궁 외 임신) [터너] 토래와 비슷한 시기에 2차 성징(가슴, 음모)이 있었나요? (난소) 목 모양, 팔 굽이 확인/지금 현재 키와 체중이 어떻게 되나요? [Prolactinoma] 두통/시야장애가 있었나요?/젖이 맺히거나 흐르나요? (머리) [쿠싱] 배에 보라색 선이 생겼나요? (내분비) 암기법 저는(전능) 난소나 머리에 내분이 일어났나 봐요.

A	[갑상샘] 더위불내성/두근거림이 있었나요?
	[PCOS] 몸에 털이나 여드름이 많은가요?
	[조기 폐경] 식은땀/안면홍조/야간 발한/불면증이 있나요?
	[정신] 우울/불안감이 있으신가요? 본인 체형에 대해 어떻게 생각하고 계세요? (신경성 식욕부진증)
F	[운동] 최근 운동을 삼하게 하셨나요? 식단 관리 중이신가요?
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 pap test 같은 산부인과 검진도 받으셨나요?
외	[외상] 복부에 외상을 입으시거나 어디 부딪히신 적 있나요? [수술] 산부인과 수술이나 시술을 받은 적 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요?(정신건강의학과 약, 항도파민 약물) (항도파민약물이라고 하면 SP가 되물을 가능성이 높은 것 같아 정신건강의학과 약 옆에 추가하는 것이 좋을 것 같습니다)
사	술, 담배, 커피는 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스가 최근 심하셨나요? [BMI] 키와 체중이 어떻게 되시나요?
가	가족 중에 유사 증상을 가진 분이 계신가요? (어머니 조기 폐경)
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 신체 검진을 위해서는 불가피하게 골반 아래쪽 노출이 필요합니다. [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) ⊕ Prolactinoma 의심 시 시야검사 시행 2. 입 : 구강 점막 3. 목* : 갑상샘 촉진 ⊕ 터너 증후군 의심 시 상의 탈의 후 유방 발달 확인 [누워서] 4. 복부 진찰* : 시-청-타-촉 5. 전신 피부 : 다모증, 여드름 6. 사지 : 피부 긴장도

술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 산부인과 진찰 : 자궁경부퍼바름검사, 질분비물검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?
----	---

월경통

☞ 먼저 오늘 문진 내용은 제가 기록은 하지만 타인은 볼 수 없고, 비밀이 유지되므로 걱정하지 마시고 편하게 말씀하시면 됩니다. 몇 가지 질문해도 될까요?

O	언제부터 아프셨나요? 초경 이후 계속 있었나요?
L	통증 부위를 짚어 주시겠어요?
D	생리 때마다 아프신 건가요? 월경 주기 중 몇 일부터 몇 일까지 아프신가요?
Co	점점 심해지시나요?
Ex	이전에도 이런 증상이 나타난 적이 있나요? → 진통제 효과?/치료는?
C = 여	[양상] 통증 양상은 어떤가요? (쿵쿵 쑤시듯이/바늘로 찌르듯이/둔하게) + NRS [정도] 안 아픈 것을 0점 가장 아픈 것을 10점이라고 했을 때 몇 점 정도인가요? [월경력] 평소 월경 주기가 어떻게 되시나요?/규칙적인가요?/LMP/임신 가능성 월경 기간은 몇 일 정도되나요? 월경량은 적당한가요? (패드 몇 장? → 월경 과다 시 자궁근종, 자궁생근육증 가능성) [초경] 초경은 언제하셨나요? [성관계] 마지막 성관계는 언제인가요?/성관계 시 통증이 있나요? (자궁내막증, 자궁근종) 모든 분들께 여쭙보는 질문이니 당황하지 마시고 혹시 평소에 성관계는 남편과만 하시나요? [산과력] 결혼은 하셨나요?/아이가 있으신가요? or 임신을 원하는데 임신이 잘 안 되나요? 혹시나 유산의 경험이 있으신가요? (최근 출산 시) 수유 중이신가요?/출산할 때 출혈이 많았나요? 임기법 TPLA + 수유/출혈 [피임] 피임은 어떻게 하시나요?

A	[전신] 발열/오한/체중 변화/피로 [일차성 월경통] 하복부 압통(A)/오심(N)/구토(V)/설사(D) → ANVD [Mass Effect] F/U/N/D, 잔뇨감/변비/복부에 만져지는 덩어리 [탈수] 어지럼증/두근거림 → 두어목 호소 암기법 월경통이 전일 있어 M자 탈모 걸릴듯
F	최근 운동을 심하게 하셨나요?
E	[건강 검진] 이전 건강 검진에서 pap test 같은 산부인과 검진도 받으셨나요?
외	[외상] 복부에 외상을 입으시거나 어디 부딪하신 적 있나요? [수술] 산부인과 수술이나 시술을 받은 적 있나요? (자궁 내 장치, 자궁소파술)
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (산부인과 질환, 골반 내 감염, 방광염)
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? (피임약, 정신건강의학과 약)
사	술, 담배, 커피는 하시나요? 직업이 어떻게 되시나요? → 스트레스를 최근 많이 받으셨나요?
가	가족 중에 유사 증상을 가진 분이 계신가요? (산부인과 질환, 월경통)
여	-
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 신체 검진을 위해서는 불가피하게 골반 아래쪽 노출이 필요합니다. 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈) 2. 입 : 구강 점막 [누워서] 3. 복부 진찰*: 시-청-타-촉 4. 사지 : 피부 긴장도
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 산부인과 진찰 : 자궁경부파파름검사, 질분비물검사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?